

Bulimia u mężczyzn

10–25% wszystkich przypadków BN, ale systematycznie niedoszacowane. Inna fenomenologia: ideał masy, sport jako kompensacja, dłuższe opóźnienie w szukaniu pomocy.

CZAS: 15 min Wywiad z mężczyzną · destygmatyzacja

ŹRÓDŁO: Murray i in. (2017); Strother i in. (2012); Pope i in. (1993)

JAK UŻYWAĆ

Zobacz **dane epidemiologiczne** dla mężczyzn (sekcja 1), poznaj **specyfikę fenomenologii** — czym różni się BN u mężczyzn (sekcja 2). Sekcja 3 — **bariery w szukaniu pomocy**. Sekcja 4 — Twoje notatki.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Hudson i in. (2007): mężczyźni stanowią **20–25% wszystkich przypadków BN**, ale systematycznie są *niedoszacowani*. Murray i in. (2017): cztery powody — stereotyp „choroby dziewcząt”, stygma kulturowa, skale walidowane głównie na kobietach, oraz **fenotyp różni się** — mężczyźni częściej dążą do *masy*, używają ćwiczeń kompensacyjnych częściej niż wymiotów. Pope i in. (1993) opisali *muscle dysmorphia* — obsesyjne dążenie do masy, równie niebezpieczne jak klasyczna AN. **Konsekwencja:** średnie opóźnienie w szukaniu pomocy u mężczyzn z BN wynosi **8 lat** vs 4 lata u kobiet (Strother i in. 2012). Wyższa komorbidalność z depresją i suicydalnością.

01 = Skala problemu — dane

20–25% WSZYSTKICH BN

Mężczyźni w badaniach populacyjnych. Hudson 2007 NCS-R. Klinika widzi mniej (~10%) — różnica = niedodiagnozowanie.

OPÓŹNIENIE 8 LAT

Średnie opóźnienie w szukaniu pomocy. U kobiet — 4 lata. Stygma + brak rozpoznania w POZ. Strother 2012.

WYŻSZA KOMORBIDALNOŚĆ

Depresja, lęk, suicydalność, nadużywanie substancji (steroidy, alkohol). Pope & Hudson 2000.

02 ◎ Specyfika fenomenologii BN u mężczyzn

IDEAŁ MUSKULATURY

Zamiast „jak najszczuplej” — „jak najbardziej masy”. Drive for muscle. Z czasem może prowadzić do nadużywania steroidów anabolicznych.

ĆWICZENIA JAKO KOMPENSACJA

Częściej niż wymioty. Wielogodzinne treningi, ćwiczenia mimo kontuzji, „cardio after binge”. Może wyglądać jak „zdrowy sport” — uwaga.

MUSCLE DYSMORPHIA

Pope (1993): obsesyjne poczucie, że ciało jest „za małe” mimo realnej masy. Lustrowanie, suplementy, izolacja społeczna.

SPORTY Z KATEGORIAMI WAGI

Sporty walki, wioślarstwo, jazda konna, kulturystyka. „Kontrolowane” odchudzanie przed wagą może maskować BN.

MNIEJ ROZPOZNAWANY KOMPONENT EMOCJONALNY

Aleksytymia jest częstsza u mężczyzn — trudność z rozpoznawaniem i nazwaniem emocji. ED u mężczyzn często wygląda jak „problem z motywacją do treningu” lub „perfekcjonizm w sporcie”. Wymaga uważnego wywiadu i czasem testów projekcyjnych.

STYGMA KULTUROWA

„ED to choroba dziewcząt”. Mężczyźni boją się oceny, że są „niemęscy”. Strach przed reakcją kolegów, partnerki, rodziny.

LEKARZE NIE PYTAJĄ

POZ rzadko pyta mężczyzn o objawy ED. Objawy somatyczne (erozja zębów, wahania masy, omdlenia) interpretowane są inaczej.

BRAK MĘSKICH GRUP

Większość grup wsparcia BN jest zdominowana przez kobiety. Mężczyznom trudno się utożsamić, mówić o specyfice męskiego ED.

INTERNALIZACJA IDEAŁU FIT

Obsesyjne ćwiczenia uznawane za „zdrowy styl życia”, restrykcja jako „dieta sportowa”. Granica między pasją a patologią rozmyta.

CO U MNIE WYGLĄDA INACZEJ NIŻ W „TYPOWYM OBRAZIE”

— ćwiczenia zamiast wymiotów, dążenie do muskulatury, sport

CO MNIE POWSTRZYMYWAŁO PRZED SZUKANIEM POMOCY

— stygma, brak rozpoznania, brak informacji o męskim ED

Klucz: bulimia **nie jest „chorobą kobiecą”** — to fenomen, który dotyka mężczyzn w 20–25% przypadków. Stygma kulturowa i niedoszacowanie kliniczne sprawiają, że *średnie opóźnienie* w szukaniu pomocy wynosi 8 lat — czyli dwa razy dłużej niż u kobiet. Każdy rok wcześniej rozpoczętego leczenia *znacząco* poprawia rokowanie. Specyfika fenotypu (ideał muskulatury, ćwiczenia jako kompensacja, sport z kategoriami wagowymi) może *maskować* bulimię — wymaga uważnego wywiadu. Murray i in. (2017): protokoły CBT-E i IPT-BN są **tak samo skuteczne** u mężczyzn jak u kobiet — wymagają jednak adaptacji do specyficznych celów (np. rozszerzenia rdzenia samooceny w pracy z muscle dysmorphia). Jeśli jesteś mężczyzną i rozpoznajesz u siebie objawy bulimii — *nie* czekaj na „typowy obraz”. Twoja forma jest **równie ważna** i wymaga leczenia. NEDA i międzynarodowe grupy mają sekcje dedykowane mężczyznom z ED.